

中医治疗消化性溃疡患者的临床疗效分析

于勇
石家庄霍文发中医骨伤医院

摘要：目的：研究中医疗法对消化性溃疡患者的治疗效果。方法：选择我院 2024 年 1~12 月就诊的消化性溃疡患者 82 例，随机分对照组和观察组，各 41 例，对照组采取西医治疗，观察组加用中医疗法治疗，观察两组治疗效果等差异。结果：观察组治疗总有效率高于对照组，观察组症状缓解时间、VAS 量表评分、溃疡愈合时间低于对照组，治疗后观察组中医证候评分、胃内 pH 值低于对照组，差异显著（ $P<0.05$ ）。结论：消化性溃疡患者的日常生活受到较大的危害，传统西医治疗见效缓慢，且对患者的治疗体验也有较大的影响，采取中医疗法治疗，可以显著提高患者的治疗效果，加强患者的症状好转效果，值得临床重视。

关键词：中医疗法；消化性溃疡；证候评分

消化性溃疡是西医病名，指患者的胃及十二指肠黏膜出现伴随溃疡病情，患者日常生活中经常出现腹痛、腹胀、恶心呕吐等症状，严重威胁患者的生命安全。且长期处于溃疡状态下，患者的营养摄入也受到较大的影响，甚至引发患者营养不良、贫血^[1]。西医临床主要以三联用药方式治疗，但效果受患者个体差异影响较大，病情控制稳定性差。中医则通过辨证用药的方式进行干预，能够针对患者个体情况进行治疗，获得较好的治疗效果^[2]。本文对所选消化性溃疡患者开展中医疗法干预，现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取我院 2024 年 1~12 月在我院消化性溃疡患者 82 例，随机分为对照组和观察组，两组各 41 例。观察组男 20 例，女 21 例，年龄 33~68 岁，平均年龄（50.41±4.68）岁，病程 4~12 年，平均病程（8.35±2.16）年；对照组男 21 例，女 20 例，年龄 32~69 岁，平均年龄（51.63±4.33）岁，病程 3~13 年，平均病程（8.48±2.77）年。患者均签署同意书，无中途离院、死亡、资料丢失等导致脱落的情况，两组一般资料比较，差异无统计学意义（ $P>0.05$ ），具有可比性。

纳入标准：（1）均符合西医的消化性溃疡诊断标准；（2）符合中医“胃脘痛”诊断标准。

排除标准：（1）消化性溃疡治疗史；（2）其他重大器官恶性肿瘤、功能衰竭；（3）意识丧失、认知功能障碍、精神类疾病患者；（4）实验用药过敏或不耐受情况。

1.2 方法

患者入院后均开展补液、维持水电解质平衡干预，同时对胃肠道功能障碍进行对症治疗。

对照组：为患者开展三联治疗，药物选择阿莫西林、奥

美拉唑、克拉霉素。其中阿莫西林（H46020182，海南省金岛制药）剂量 1g/次，bid，奥美拉唑（H20054926，生命科技生物制药）剂量 20mg/次，bid，克拉霉素（H20033044，上海雅培制药）剂量 0.5g/次，bid，上述药物分别在早晚餐前用药，连续用药 1 个月。

观察组：对照组基础上采取中医用药治疗，根据患者的辨证分型进行用药，如寒热错杂证利用黄连温胃饮加减治疗，方剂包括黄连、吴茱萸、党参、炙甘草等；肝胃不和证利用柴胡疏肝散加减治疗，方剂包括柴胡、黄芩、法半夏、陈皮等。脾胃虚弱证利用香砂六君子汤加减治疗，方剂包括党参、白术、茯苓、炙甘草、木香、砂仁等药物组成。1 剂/日，清水浸泡煎煮后取汁 400ml，分早晚餐前用药，200ml/次，连续用药 1 个月。

1.3 观察指标

（1）对比两组治疗总有效率=痊愈+显效/41*100%。痊愈：患者的溃疡部位彻底愈合，形成部分瘢痕，炎症反应彻底清除；显效：患者溃疡面积缩小 50%及以上，炎症反应好转，为见新溃疡面生成；无效：未达到上述标准。

（2）对比两组症状缓解时间、VAS 量表评分、溃疡愈合时间差异。

（3）对比两组治疗前后中医证候评分、胃内 pH 值差异。

1.4 统计学方法

使用 SPSS 27.0 分析数据，计数资料和计量资料分别以（%）、（ $\bar{x}\pm s$ ）表示，并分别进行 χ^2 和 t 检验，均以 $P<0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗总有效率比较

观察组治疗总有效率高于对照组，差异显著（ $P<0.05$ ），见表 1。

表 1 两组治疗总有效率比较（%）[n（%）]

组别	例数	痊愈	显效	无效	治疗总有效率
观察组	41	25（60.97）	14（34.16）	2（4.87）	39（95.13）
对照组	41	18（43.90）	15（36.59）	8（19.51）	33（80.49）
χ^2	-				7.51
P	-				$P<0.05$

表2 两组症状缓解时间、VAS 量表评分、溃疡愈合时间对比 ($\bar{x} \pm s$) [n (天)]

组别	例数	症状缓解时间	VAS 量表评分 (分)	溃疡愈合时间
观察组	41	5.48±1.63	2.14±0.63	26.58±5.13
对照组	41	9.58±1.34	5.74±0.45	33.78±7.02
t	-	10.2843	11.6624	10.8831
P	-	P<0.05	P<0.05	P<0.05

表3 两组治疗前后中医证候评分、胃内 pH 值对比 ($\bar{x} \pm s$) [n (分)]

组别	例数	中医证候评分		胃内 pH 值	
		干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	41	8.65±1.63	2.11±0.21	1.12±0.32	2.18±0.21
对照组	41	8.44±1.25	4.35±0.77	1.88±0.41	1.75±0.44
t	-	2.6654	10.5132	2.7715	11.6352
P	-	P>0.05	P<0.05	P>0.05	P<0.05

2.2 两组症状缓解时间、VAS 量表评分、溃疡愈合时间对比

观察组症状缓解时间、VAS 量表评分、溃疡愈合时间低于对照组,差异显著 (P<0.05),见表2。

2.3 两组治疗前后中医证候评分、胃内 pH 值对比

治疗前两组中医证候评分、胃内 pH 值无显著差异 (P>0.05),治疗后观察组中医证候评分、胃内 pH 值低于对照组,差异显著 (P<0.05),见表3。

3 讨论

中医将消化性溃疡归结为“胃脘痛”,对胃脘痛的治疗有十分成熟的临床经验。中医临床研究显示,消化性溃疡多以寒热错杂证、肝胃不调证、脾胃虚弱证为主,分别开展针对性用药,如利用黄连温胃饮加减治疗寒热错杂证患者,可以起到清胃泻肺、扶正固本的效果,其中小檗碱可以对幽门螺杆菌产生较好的杀除效果,且在抗炎方面的作用更高^[3-4]。肝胃不调证通过柴胡疏肝散治疗,可起到疏肝理气、清热泻火的目的,同时对调节机体免疫功能,提高抗炎效果有较大的帮助。脾胃虚弱患者则通过香砂六君子汤治疗,可以产生补脾益气、理气和胃的效果,那个能够产生较好的抗溃疡、抗炎效果^[5]。上述方剂均具有明显的保护黏膜、加快黏膜修复的作用,因此在消化性溃疡的治疗当中效果更高。与西药联合用药,则可以显著提高患者的康复效果。

本次实验表明,观察组治疗总有效率高于对照组 (P<0.05),说明在对消化性溃疡患者开展治疗时,单纯通过西药治疗的效果相对较低,且在治疗期间易发生不良反应,导致患者的用药依从效果较差,无法获得长期、稳定的用药效果。在此基础上加用中药方剂辨证治疗,可以显著提高患者的治疗效果,中药治疗可以根据患者的病情进行辨证用药,以提高其用药的安全性,使患者能够更加稳定的完成治疗疗程,为提高患者治疗效果有明确的作用。观察组症状缓解时

间、VAS 量表评分、溃疡愈合时间低于对照组 (P<0.05),则说明在对消化性溃疡患者开展中药治疗后,患者的腹痛、腹胀、恶心嗳气等症状得到更快的缓解,患者的疼痛感得到有效控制,因此可以显著提高患者的治疗体验。中药治疗下患者得到溃疡愈合时间也得到有效缩短,说明在西药治疗基础上,采取中药治疗可以更快的修复胃肠道黏膜,对保护胃肠道黏膜也有较大的帮助,可以有效巩固患者溃疡愈合效果,避免溃疡新生。治疗后观察组中医证候评分、胃内 pH 值低于对照组 (P<0.05),说明通过中医辨证用药,可以有效清除消化性溃疡的症状表现,对缓解患者不适有更好的效果,同时可以有效控制患者的 pH 值,缓解胃酸分泌过多影响胃内环境,避免由于胃内 pH 过低增加消化道黏膜的损伤,通过改善 pH 值的方式,加强对胃黏膜的保护效果。

综上所述,对消化性溃疡患者开展中医治疗效果更高,值得临床重视。

参考文献:

[1]陈莎莎.中西医结合治疗消化性溃疡(肝胃不和证)临床疗效观察[J].内蒙古中医药,2025,44(7):13-15.
[2]赵长城.香砂六君子合失笑散加减治疗消化性溃疡(脾虚肝郁证)对中医证候积分及复发的影响[J].四川中医,2024,42(2):121-125.
[3]魏红刚,白丽娜.中医辨证对消化性溃疡合并幽门螺杆菌感染治疗效果及清除率分析[J].婚育与健康,2023,29(24):103-105.
[4]董庆阳.中医治疗100例消化性溃疡的临床疗效分析[J].中国医药指南,2020,18(21):177-178.
[5]王济邦,应勇强,吕霞.中医药改善消化系统疾病常见病症的回顾性研究与药物机制分析[J].中医药管理杂志,2024,32(19):84-86.